

MEDQUERY AI - DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CLÍNICO

ID Documento: MQ-EPI-202

Título: Protocolo de Sospecha y Reporte Epidemiológico de Dengue

Diagnóstico Presuntivo: Síndrome Febril Agudo Inespecífico (Dengue)

Síntomas Guía: Fiebre alta, cefalea, dolor retroocular, mialgias, exantema

Especialidad: SPEC_EMERG

Versión: v1.2 (Agosto 2026)

Población Objetivo: Adulto y Pediátrico

Medical Owner: Comité de Epidemiología

BLOQUE DE ACCIÓN INMEDIATA - TRIAGE: URG_L3_YELLOW

Acción de Primera Línea: Notificar de forma inmediata ante la sospecha clínica. Completar la Ficha de Notificación Epidemiológica (Formulario de Alerta Nacional) dentro de las primeras 24 horas del contacto inicial. Indicar aislamiento entomológico en la guardia (uso de repelente cada 4 horas y mosquitero).

Drogas de Elección:

- **Antipirético / Analgésico Único:** Paracetamol 500 mg a 1 g cada 6 horas VO (Dosis máxima en adultos: 4 g/día). En pediátricos: 10-15 mg/kg/dosis.
- **Hidratación:** Hidratación oral agresiva con líquidos caseros o sales de hidratación oral (mínimo 2 a 3 litros diarios en adultos).

Alerta de Seguridad / Contraindicación Crítica: Totalmente contraindicado el uso de Ácido Acetilsalicílico (Aspirina), Ibuprofeno, Diclofenac, Naproxeno o cualquier otro Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE), así como la vía intramuscular. El uso de estas drogas incrementa de forma crítica el riesgo de sangrados y falla hemodinámica por trombocitopenia refractaria.

1 Definición de Caso Sospechoso

Se considera caso sospechoso a todo paciente que presente fiebre de menos de siete (7) días de duración, sin afección de las vías aéreas superiores ni otra etiología evidente, acompañada de dos o más de los siguientes signos:

- Cefalea intensa y dolor retroocular característico.
- Mialgias y artralgias incapacitantes (fiebre quebrantahuesos).
- Exantema maculopapular predominantemente pruriginoso.
- Leucopenia o plaquetopenia constatada en hemograma de control.

2 Clasificación Clínica y Evaluación de Gravedad

Para orientar la derivación o internación, el profesional de la guardia debe estratificar al paciente en uno de los siguientes tres grupos operativos:

1. **Grupo A (Dengue sin signos de alarma):** Pacientes que toleran la vía oral, tienen diuresis normal y no presentan comorbilidades ni factores de riesgo. Manejo ambulatorio con control diario.
2. **Grupo B (Dengue con signos de alarma o co-morbilidad):** Pacientes que presentan dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural), sangrado de mucosas, letargo o hepatomegalia > 2 cm. Requieren internación en sala general.
3. **Grupo C (Dengue grave):** Pacientes con choque hipovolémico por fuga de plasma, sangrado severo evaluado por clínica, o daño orgánico grave (miocarditis, encefalitis, transaminasas > 1000 U/L). Requieren derivación inmediata a la Unidad de Cuidados Intensivos (SPEC_ICU).

3 Circuito Obligatorio de Notificación y Toma de Muestras

El incumplimiento del reporte epidemiológico genera infracciones administrativas graves para el centro de salud. El procedimiento estandarizado es el siguiente:

1. **Registro:** Completar la planilla física de Síndrome Febril Agudo inyectando los datos de filiación del paciente.
2. **Extracción:** Realizar toma de muestra de sangre entera (tubo seco o con EDTA) para determinación virológica o serológica.
3. **Logística de Laboratorio:** Enviar la muestra refrigerada ($2 - 8^{\circ}\text{C}$) al laboratorio central del hospital antes de cumplirse las 24 horas del ingreso.
4. **Carga Digital:** El personal administrativo de guardia migrará los datos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).